



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : سحر حسن قرنى احمد

العنوان : 5 ش 11 - مدينه
الشمس

الحي / المدينة : مصر القديمه

المحافظة : القاهرة

تاريخ تسجيل الإستمارة : 26-09-2026

رقم البطاقة : 28102100104663 رقم التليفون : 01113082463

العمر(تاريخ الميلاد) : 10-02-1981 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-
الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة
نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي (.....)
المقر بما فيه (.....)
التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : جراحات أورام تدخل جراحى لاستئصال كامل /تحفظى للثدى +تفريغ قسم العلاج :
الغدد الليمفاوية و/ او الغدد الحارسة [13155]
التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة:
الوظيفة:
الوظيفة:
التوقيع:
التوقيع:
التوقيع:
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس
وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض
بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

..... /د. /د. /د. /د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
جهة العلاج :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

Name: سحر حسن قرني احمد
National ID: 28102100104663



تقرير طبي

السيد

تحية طبية وبعد,,

بشأن تقرير طبي للمريض

إيماء للطلب المقدم من

رقم طبي:

بقسم:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته

تاريخ وساعة الخروج :
PM 01:17 05-07-2026

تاريخ وساعة الدخول :
-- --:-- yyyy-mm-dd

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الى Mastectomy or breast-conserving surgery with axillary lymph node
dissection and/or sentinel lymph node biopsy

الوقت :

-- --:--

التاريخ :

05-07-2026

الطبيب المعالج :
د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة هوية شخصية

بمحر
حسن قرني احمد
٥ ثمن ١٩ - مدينة شمس
حلوان - القاهرة

١٩٨٧-٠٢-٢٨ ٢٨١٠٢١٠٠١٠٤٦٦٣

JJ8483320

فتح ملف
راكان شهاب
١١/١١
٢٠١٩

٢٢-١
٥
٤٤
جراح
٠١١١٣٠٨٤٤٦٤

٢٠٢١-٠٢-٢٨ ٢٨١٠٢١٠٠١٠٤٦٦٣

بكالوريوس تنظيم لائق والتربية
شعبة صناعات معنية
مجلس
مسترجعة
حسام عبد المنعم حسن محمد ريد
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٩/٠٢/٢٨

١

MDT FORM 24/12/2025 G

<u>Name</u>	سحر حسنی قرنی	<u>MRN</u>	3301 / 2-25
		<u>ID</u>	C11.C1.1.1.477
<u>Age</u>	44y	<u>Phone</u>	0111 3082463
<u>Menopausal status</u>	irregular	<u>Marital status</u>	Married
<u>NRS SCORE</u>		<u>Family history</u>	— none
<u>BMI</u>		<u>REASON OF MDT</u>	new case
<u>CO morbidity</u>	NAD		

Clinical Data			
BX: <u>R+</u> IDC <u>Lt</u> granulomatous mastitis			
ER: 418	PR: 418	HER 2: 0	Ki67: 50%
Sonomammography: 24x23 mm UO 9 mass upper central cystic lesion granulomatous mastitis			
Mets Workup: CT → Free			
Recommendations: - AS week + 14. T 1C' 50 - Clipping - NA AC x 4 Trel 12 week + fertility counseling			
MDT OUTCOME & PLAN Lt Gm will be managed with immunosuppression effect of chx + steroids to be followed up closely			

SIGNATURE					
MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
<i>M. K. K.</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		



MINISTRY OF HEALTH

قسم الباثولوجي

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
المعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي
والأمراض المعدية

PATHOLOGY DEPARTMENT HISTOPATHOLOGICAL REPORT

Patient name: سحر حسن قرني احمد
Request type: مبادر
Hospital no:
Department: صحة مرآة
Referred by: د/مروءة حسن
Nature of specimen: tru-cut biopsy
Clinical diagnosis: bilateral breast masses

Age: 44years
Sex: female
Sub request type:
Pathology no.: 625B -2025
Date of result: 16/10/2025
Date of biopsy: 8/10/2025
I.D. Number: 28102100104663

Gross pathology: Two specimens were received and designated as:

- (1) Right: Four gray white cores up to 1 cm long each, totally submitted.
- (2) Left: tiny fragmented gray brown tissue measured 0.5 cm, totally submitted.

Immunohistochemical technique used for the right side:

Sections from the right side were prepared from the paraffin block, processed in Benchmark Ultra machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter-stain. The sections were treated against: ER- PR- Her2- Ki67

Microscopic picture:

- 1- Right Side: Sections examined revealed breast tissue core showing invasive duct carcinoma (NST). Tumor forms sheets, clusters, cords and trabeculae infiltrating among desmoplastic stroma with areas of necrosis. Tumor cells showed moderate anaplasia with moderate tendency to form tubules and mitosis. There is no DCIS in the examined tissue. The surrounding breast tissue showed inflammatory infiltrate.
- 2- Left Side: Section examined revealed mammary core tissue with lobulocentric granulomatous inflammation formed of multinucleated giant cells, lymphocytes, plasma cells and eosinophils within and around the lobules. No dysplasia or malignancy in core tissue examined.

Immunohistochemistry: of Right side:

ER: Moderate nuclear staining in 10% of tumor cells (4/8).
PR: Moderate positive nuclear staining of 5% of the tumor cells (4/8).
Her2: No membranous staining of tumor cells (Score 0)
Ki67: Positive nuclear staining of 50% of tumor cells.

Diagnosis: Bilateral Breast Masses, Tru-Cut Biopsy:

- 1-Right mass: Invasive Ductal Carcinoma, (NST) Grade II.
(ER 4/8, PR 4/8, Her2 Score 0, Ki67 50%).
- 2-Left mass : Granulomatous Mastitis, For Clinical & Radiological Correlation

Signature:

Dr.Nermine Nabil.M.D

Dr.Mona Mohamed.M.D

Pathology Lab. Manager

Nermine Nabil, M.D

Sahar hassan garny

24-11-2025

Bilateral Digital soft tissue mammography with high resolution breast sonography revealed:

Clinical summary: known right breast malignant process and left granulomatous mastitis

Findings:

Right breast

- Scattered fibroglandular densities.. (ACR b)
- UOQ speculated dense mass is seen
- By complementary ultrasound, an ill defined hypoechoic mass is seen at 11 oclock zone b measuring 24 x 23 mm
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Non-specific axillary LNs.

Left breast

- Scattered fibroglandular densities. (ACR b)
- Upper central area , focal asymmetry with no speculations, masses, distortion or suspicious microcalcifications.
- Ultrasound demonstrated 12 o'clock, well defined hypoechoic cystic lesion measuring 1.4 x 0.6 cm
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Non-specific axillary LNs.

Conclusion:-

Right breast (BIRADS 6): UOQ malignant mass

Left breast (BIRADS 3): upper central cystic lesion proven to be granulomatous mastitis

Dr farah elshobaky

Patient Name: Sahar Hassan Qorany Ahmed	Date : 18/11/2025
Exam : CT CAP+C (CT Chest Abd. Pelvis)	Age : 44 Year(s)
Medical ID: 3101/2025	Pat. ID: 133017

MULTISCLICE POST CONTRAST C.T. EXAMINATION OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS

REVEALED:

Known case of CA breast. No available previous films for comparison.

I- CHEST:

- Right breast lesion, with peripheral contrast enhancement measuring 27 x 19 mm, and few small left breast nodules for sono-mammography.
- No pulmonary nodules, masses or cavitary lesions.
- No consolidation or collapse.
- No hilar or mediastinal masses or lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collection.
- Normal CT appearance of the heart and great vessels.

II- ABDOMEN AND PELVIS:

- Average sized liver showing homogenous parenchymal attenuation. No hepatic focal lesion or dilated biliary radicles.
- Both kidneys are normal site, average sized and showing smooth regular cortical outline and preserved parenchymal thickness and function. No stones or back pressure changes.
- Normal C.T appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, aorta and IVC.
- The urinary bladder shows no evidence of gross masses or diverticulae or stones.
- IUCD is seen within the uterus.
- Normal appearance of the pelvic organs with no pelvic masses or collections.
- Few subcentimetric mesenteric lymph nodes.
- No ascites.
- No worrisome lytic or sclerotic bone lesions.

Opinion:

- ❖ Known case of CA breast showing no pulmonary nodules, hepatic focal lesions or worrisome lytic or sclerotic bone lesions.

Dr. Sherif Wagdy

Dr. Sherif Wagdy

Patient Name:	Sahar Hasan Kotany	Sex:	F
Patient Id:	28102100104663	Age:	44Y 7M
Study:		Accession:	
Date:	15/09/2025	Thank you for referring this case.	
Dear Prof. Dr.			

Bilateral breast sono-mammography REVEALED:-

- **Mammography:**

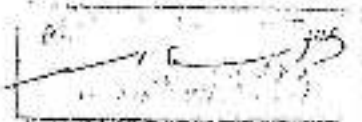
- **ACR: B**

- Both breasts show fairly defined isodense lesions , no suspicious microcalcifications by ultrasound revealed ill defined hypoechoic solid lesions, with internal vascularity surrounding tissue distortion, both located at 11 o'clock , at left side measures 13x10mm ,at the right side measures 21x19mm
- Both axilla showing reactive LNs with preserved fatty hila

Conclusion :

- Bilateral suspicious breast lesions , BIRADS IV c For Biopsy .

Dr/ Sanaa Mohamed ,FEBR



63/37-111C197V
FNAK BIL B
15/09/2025
10:48:50 AM

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

سحر
حسن قرني احمد
ش ١١ - مدينة النسي
حلوان - القاهرة

٢٨١٠٢١٠٠١٠٤٦٦٣

JJ8483320

٢٠٢٢/٠٥ ٢٨١٠٢١٠٠١٠٤٦٦٣

بكالوريوس التعليم الفني والتربية
شعبة صناعات معدنية ١٩٩٧
انقر مسممة
حسام عبدالمنعم حسن محمد زيد
البطاقة مملوكة لحضري ٢٠٢٢/٠٥/٢٠٢١

جمهورية مصر العربية
وزارة الداخلية
بطاقة تحقيق الشخصية

سحر
حسن قرني احمد
هـ ش ١١ - مدينة الشمس
خوان - القاهرة

٢٨١٠٢١٠٠١٠٤٦٦٣

JJ8483320



٢٠٢٢/٠٦ ٢٨١٠٢١٠٠١٠٤٦٦٣
مكثوريوس التعليم الفني والتربية
شعبة صناعات معدييه
التي مسلمة
متروجة
حسام عبدالمنعم حسن محمد زيد
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٩/٠٥/٣١



سحر



DMS

منزله من رة جاعه الفصول





09/20/2026

MDT FORM

Name:	Sahar Hassan Orane	MRN:	1323
Age:	46 Y	ID:	28102100104663
Menopausal Sta	pre	Phone:*	01113082463
NRS SCORE:		Marital Status:	
BMI:		Family History:	-ve fh
Gender		Reason Of MDT:	
CO Morbidity:	m. free	post nact	
Surgical History:*	nad	ECOG Performance Status	0 0 1 0 2 0 3 0 4

Clinical Data:

R L

BX:

ER: PR: HER2: KI67:

History:

PREM RT BREAST CANCER CT2 NO MO BY CTS clips inserted ER4/8 PR
4/8HER2 -VE KI67 50% WITH LEFT GRANULOMATOUS MASTITIS
pt rec 4 ac 12 weeks taxol last 20/8/2026

Sonomammography:

cesm rt uoq clip is noted with mild diffuse skin thickening
no evidence of pathological mass or non mass enhancement
axillary ln of average cortical thickness birads 6
lt breast pathological proven granulomatous mastitis birads 2

T N M

Right Side				Left Side			
Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4

Biomarker/Molecular

Clinical Staging:

Mets Workup:

Pathological Staging:

Recommendations:

after examination at surgical clinic for rt wle after wire localization + sinb
as planned

MDT Outcome & Plan

rt wle after wire localization + sinb as planned

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY
د. خالد عبد العزيز	د. محمد نوراني		

الاسم المرضي: بالإنجليزية: Sahar Hassan Karni Ahmed	كود المرضي: 99170
تاريخ التقرير: 2026/09/09 09:25:43 AM	السن سنة شهر

Contrast enhanced Spectral Mammography

CLINICAL SUMMARY:

- Right breast malignant mass pathologically proved to be invasive duct carcinoma, grade II, underwent NACT, for response assessment.
- Left breast inflammatory process, pathologically proved to be granulomatous mastitis.

TECHNIQUE:

- CC & MLO low energy & recombined (post contrast) images

FINDINGS:

Background Uptake: mild background enhancement
ACR: c (heterogeneously dense breast parenchyma).

Right BREAST:

- **Low energy (Non contrast) images:** Upper outer quadrant inserted clip is noted along with mild diffuse skin thickening.
- **Recombined (Post contrast) images:** No evidence of pathological mass or non-mass enhancement in today's study. By **complementary US**, corresponding 10 o'clock area of distortion is noted with the inserted clip seen within.
- Normal nipple / areolar complex.
- The examined level I axillary lymph nodes show average cortical thickness and preserved fatty hila.

LEFT BREAST:

- **Low energy (Non contrast) images:** marked diffuse skin thickening is noted along with retroareolar focal asymmetry and coarsened trabeculae.
- **Recombined (Post contrast) images** show diffuse nodular non-mass enhancement likely secondary to residual inflammatory changes. By **complementary US**, diffuse skin thickening with interstitial edema is noted, yet with no evidence of gross masses or collections.

IMPRESSION:

RIGHT BREAST: Status post NACT for right breast malignant process showing no pathological enhancement in today's study denoting complete radiological response (BIRADS 6).

LEFT BREAST: Pathologically proven granulomatous mastitis with residual breast edematous changes (**BIRADS 2= normal**)

Best regards,

Dr. Sherihan Fakfury, MD